EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 93833
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 02-10-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MIRIAM DEL CARMEN MARIANGEL FUENTES			RUN	: 9.262.855-8
F.Nac	: 11-09-1954	Edad	: 70 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: LOS POETAS J.MONTES 40			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 68128115		
Fecha Ingreso	: 2024-09-25	Fecha Egreso	: 02-10-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R56.8-OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Síndrome sensitivo- motor derecho
1.1 ACV isquémico talámico izquierdo
1.2 Etiología lacunar
2. Delirium mixto resuelto
3. DM II IR
4. Obs ICC
5. Sospecha de enfermedad pulmonar intesticial
6.Obessidad tipo 2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63-INFARTO CEREBRAL (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. E10-DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. E66-OBESIDAD. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

ANTECEDENTES MÉDICOS:
HTA/ DM II IR/ obesidad/ sospecha de ICC/ sospecha de enfermedad pulmonar intersticial

Paciente femenino de 70 años mRS previo 2 puntos. cuyo familiar refiere inicio de cuadro clínico el día 24/09 en horas de la mañana cuando presenta dificultad leve para articulación de las palabras asociado a inestabilidad postural con lateralización a derecha. Posteriormente se asocia desorientación temporo-espacial y compromiso de conciencia caracterizado por sonmolencia. En este contexto es trasladada por familiares a SU HSC para evaluación médica. A su ingreso destaca hiperglicemia sostenida asociado a hipotensión. Se solicita evaluación por neurología, donde posterior a evaluación clínica y radiológica se decide su ingreso para manejo médico intrahospitalario.

EVOLUCIÓN INTRAHOSPITALARIA:

¨* NEUROLÓGICO: paciente que ingresa en regulares condiciones generales. A su ingreso se observa compromiso de conciencia con tendencia a somnolencia, con posterior objetivación de síndrome sensitivo motor derecho. Paciente que evoluciona de forma satisfactoria. En contexto de lesión hipodensa talámica izquierda que contribuye a compromiso de conciencia, se inicia tratamiento con metilfenidato de liberación inmediata con buena respuesta, logrando mejoría del estado de alerta y vigilia con mayor incorporación y colaboración con terapia de rehabilitación kinésica y fonoaudiológica, logrando alimentación con régimen papila y blando por vía oral y realizando ejercicios de estimulación cognitiva y de activación y fortalecimiento muscular. Actualmente se indica uso de órtesis para re-educación de la marcha y prevención de caídas.

* METABÓLICO: paciente con antecedentes de DM II IR con usos de insulina suspendido por cuenta propia. A su ingreso destacan cifras de glicemia elevadas (> 300 mg/dl). Se inicia tratamiento con insulina cristalina en esquema de rescate con posterior inicio de insulina NPH logrando mejor control metabólico. Durante hospitalización presenta tendencia a la somnolencia, pesquisándose aumento en niveles plasmáticos de sodio. Se maneja con administración de agua libre de sodio vía oral, con normalización de valores de laboratorio y mejoría de estado de conciencia.

EXAMEN NEUROLÓGICO DE ALTA:

Paciente en regulares condiciones generales, afebril, eupneica, hidratada. Con hemodinamia con tendencia a hipotensión. Sin uso de DVA ni O2 suplementario.
SIGNOS VITALES:
PA: 126/72 mmHg/ FC: 84 LPM/ FR: 12 RPM/ SATO2: 96% con fio2 21% HGT: 202 mg/dl

EXAMEN NEUROLÓGICO:
- MENTAL: vigil espontánea, inatenta, orientada en espacio mas no en tiempo. Lenguaje Nomina 5/5, repite frases simples 5/5, comprende órdenes y comandos de forma sistemática, disartria hipotónica leve.
- PC: pupilas medias, normoreactivas. RFM directo y consensual +/+. CV impresiona conservado a la amenaza. Mirada inicial en posición central sin mirada preferente. OCM sin alteraciones. Asimetría facial por PFC leve a derecha. Protruye lengua en línea media al comando.
- MOTOR: hemiparesia BC disarmónica derecha de predominio braquial M3/ M4+. REM +/++. RCP flexor bilateral asimétrico a derecha. Hoffman negativo bilateral.
- SENSITIVO: retiro asimétrico a derecha a estímulos dolorosos apendiculares.
- TAXIAS: conservadas
- Signos meníngeos negativos
NIHSS: 5 PUNTOS

En contexto de buena evolución intrahospitalaria se decide alta médica con HODOM y control en policlínico de especialidades según corresponda.

PLAN DE MANEJO:

1. Alta domiciliaria con HODOM --> REFORZAR TERAPIA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
2. Mantener medidas de neuroprotección establecidas (aspirina + atorvastatina+ clopidogrel)
3. Control y seguimiento en policlínico de medicina interna
4. Control y seguimiento de patologías crónicas en consultorio de APS correspondiente
5. Pendiente realizar estudios complementarios pendientes

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo. Caminar con asistencia y uso de ayuda técnica
2. 2. Dieta de estilo mediaterráneo: Procure tomar alimentos ricos en fibra, minerales y antioxidantes. Tome al menos tres piezas de fruta al día, preferentemente de temporada y un puñado de frutos secos crudos (nueces, almendras…) 3 a 7 veces por semana; evite los frutos secos procesados por que pueden perder sus propiedades y/o o les pueden añadir grasas no saludables. Incorpore diariamente a su dieta cereales y derivados preferentemente integrales (pan, arroz, pasta…). Coma legumbres entre dos y cuatro veces por semana. Tome verduras y hortalizas al menos dos veces al día. Una de las tomas que sean crudas (ensaladas generalmente). Use preferentemente aceite de oliva virgen tanto para cocinar como para condimentar ensaladas. Disminuya en su dieta el consumo de grasas animales (como mantequilla, tocino, bollería industrial, carnes grasas, embutidos, quesos, bacon, natas…)
3. 3. Aspirina 100 mg vía oral/ diario a las 10:00 a permanencia
4. 4. Atorvastatina 40 mg: 2 comprimidos vía oral a las 21:00 horas a permanencia
5. 5. Clopidogrel 75 mg: 1 comprimido vía oral/ diario por 3 meses (tomar diariamente hasta el 24 de diciembre de 2014. Luego de esa fecha suspender)
6. 5. Insulina NPH 16 UI vía subcutánea en la mañana + 8 UI vía subcutánea en la noche
7. 6. Metformina 850 mg: 1 comprimido vía oral cada 8 horas (antes de cada comida)
8. 7. Carvedilol 6.25 mg cada 12 horas
9. 8. Bromuro de ipratropio: 2 puff cada 6 horas
10. 9. Evaluación en policlínico de medicina interna
11. 10. Realizar de forma ambulatoria: ecocardiograma TT + Holter del ritmo de 48 horas

12. 11. Control en policlínico de neurología (Dr. Roger Molleja) en 15-30 días con resultados de exámenes complementarios

EXÁMENES Y RESULTADOS

* TAC- AngioTAC de cerebro y cuello (24/09): Se observa lesión hipodensa talámica izquierda sin signos de transformación hemorrágica. Ateromatosis cálcica en sifones carotídeos sin estenosis. Estenosis moderadamente significativa en segmento P2 proximal de ACP derecha de aspecto ateromatoso.
* TAC de cerebro S/C control (25/09): se observa lesión de aspecto isquémica de aspecto sub- agudo consolidada talámica izquierda.

OBSERVACIONES:

- control en policlínico de neurología con Dr. Roger Molleja en 15-30 días con resultado de ecocardiograma TT + HOLTER DEL RITMO

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

ROGER DE JESUS MOLLEJA MARAIMA
MEDICO TRATANTE
26127229-6

JEFE SERVICIO